

ИБС, бронхолегочная патология. Все это неблагоприятным фактором ложится на решение по выбору лечения онкологического больного.

Современная врачебная практика диктует прямую необходимость комплексного подхода к изучению клиники возникновения и развития сочетанных заболеваний, что заставляет по-новому взглянуть на проблему полиморбидности.

ТҰЖЫРЫМ

С.К.Макулбекова

Б.Н. Ельцин атындағы Қырғыз – Ресей Славяндық университет

Асқазан және ұйқы безі нәтижелері науқастардың қатерлі ісігі полиморбидностің әсері арналған емдеу

Асқазан қатерлі ісігінен (19 науқас) және ұйқы безі қатерлі ісігінен (36 науқас), 2012 жылы Ұлттық онкология орталығында ем алып жатқан науқастардың ауру тарихына ретроспективті талдау жүргізілді. Анықталған полиморбидность науқастарда, әсер етеді ішінде қатерлі процестің және емдеу нәтижелері.

Түйінді сөздер: полиморбидность, асқазан қатерлі ісігі, ұйқы безі қатерлі ісігі.

Список литературы

1. Николаев Ю.А., Шкурупий В.А. Проблема полиморбидности в современной терапевтической клинике // Материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» – Новосибирск, 2015.- С.194-195.
2. Полторацкий А.Н, Рынак Г.А., Ильницкий А.Н. Факторы, влияющие на клинический выбор врача при назначении специфического лечения рака легкого в пожилом и старческом возрасте // Мат. 9-й Респуб. Конф. - Казань, 2002.- С. 57–61.
3. Наумов А.В. Полиморбидные состояния в практике врача и комплексный подход к их коррекции: лекция. – М., 2012.
4. Reck M. Phase 111 Trial of Cisplatin Plus Gemcitabine with Either Placebo or Bevacizumab as First-Line Therapy for Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer: AV Ail / J. Clin. Oncol., 2008. – Vol.27. – P.1227–1234.
5. Рыбалко В.Д. Параметрическое диагностирование энергетических объектов на основе факторного анализа ТВ среде STATISTICA” //Exponenta”. Pro 2, 2004. – № 6.

SUMMARY

S.K. Makulbekova

Boris Yeltsin Kyrgyz - Russian Slavic University

Influence of polymorbidity on the results of treatment of patients with gastric cancer and pancreatic cancer

We made retrospective analysis of records of patients with gastric cancer (19 patients) and pancreatic cancer (36 patients) treated in the National Center of Oncology in 2012. The identified polymorbidity has influenced the malignant process and the treatment outcomes.

Keywords: polymorbidity, stomach cancer, pancreatic cancer.

УДК:616.351.37-006.6

¹Олжаев С.Т., ²Сейсембаев М.А., ³Лазарев А.Ф.

¹ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер», г. Алматы

²НУО Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы, Республика Казахстан

³Алтайский филиал Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, г. Барнаул, Российская Федерация

Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных раком головки поджелудочной железы и ее клинические результаты

Аннотация. С целью анализа изменений эндотелиальной функции после оперативного вмешательства на фоне коррекции были обследованы 95 оперированных больных со II и III клинической стадиями рака головки поджелудочной железы. Исследованы показатели функции эндотелия и содержание циркулирующих эндотелиоцитов.

При использовании в комплексном лечении L-аргинина и ингибитора АПФ выявлено снижение степени повреждения эндотелия, коррекция эндотелиальной дисфункции. Применение разработанных методов лечения способствовало также уменьшению числа осложнений.

Ключевые слова: рак головки поджелудочной железы; эндотелиальная дисфункция; L-аргинин; ингибитор ангиотензин-превращающего фермента.

Введение. Общее состояние организма играет важную роль в определении результатов оперативного и консервативного лечения злокачественных новообразований [1-3]. К числу параметров этого состояния относится наличие или отсутствие нарушений системной и региональной гемодинамики, дыхания, показателей функционирования биохимических систем, продукции и утилизации гормонов и т.д. [4,5]. Универсальным аспектом в данном случае является также функция сосудистого эндотелия, зависящая от его морфологии, в том числе, непосредственно в опухоли.

Микроокружение эндотелия в опухолевой ткани, хроническая гипоксия эндотелиоцитов, частое повреждение сосудов определяет формирование системных механизмов, направленных на активацию сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, вазоконстрикцию, продукцию факторов роста и провоспалительных цитокинов [6].

Развитие рака головки поджелудочной железы обычно сопряжено с выраженными метаболическими нарушениями, интоксикационным синдромом, синдромом мальабсорбции и мальдигестии, что ухудшает общее состояние пациентов и повышает риск негативных результатов лечения [7]. В этих условиях улучшение системных параметров гемоциркуляции может быть фактором, способствующим значительному повышению результатов оперативного лечения.

Цель исследования: анализ изменений эндотелиальной функции у больных раком головки поджелудочной железы после оперативного вмешательства на фоне коррекции.

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 95 больных со II (T3N0M0 (2а), T1-3N1M0 (2b)) и III (T4N1M0) клинической стадиями рака головки поджелудочной железы (45 и 50 пациентов соответственно), в том числе, 66 мужчин и 29 женщин в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 60,8±2,1 года). Все больные подвергались комбинированной терапии, включавшей радикальное хирургическое лечение в виде операций гастропанкреатодуоденальной резекции или панкреатодуоденальной резекции.

Из исследования были исключены больные с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями. Обязательным критерием включения было наличие информированного согласия на осуществление дополнительных методов консервативного лечения и анонимное использование полученных данных в научном исследовании.

Все больные были распределены на 2 группы в зависимости от наличия дополнительной терапии в периоперационном периоде, направленной на коррекцию эндотелиальной дисфункции. Между пациентами выделенных групп не было существенных различий по возрасту, полу, стадии новообразования, локализации опухоли в желудке, тяжести состояния в предоперационном периоде, сопутствующим заболеваниям и проведенным оперативным вмешательствам.

В качестве контрольной группы обследованы 40 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 57,3±2,0 года).

Исследованы показатели функции сосудистого эндотелия: содержание десквамированных (циркулирующих) эндотелиоцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон Виллебранда (ФВ) в плазме и степень эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) [8].

Клинические результаты рассматривались в плане выявления осложнений в раннем послеоперационном периоде (гнойно-септические, тромботические) и при проспективном наблюдении сроком 2,1±0,1 года в основной группе и 2,0±0,2 года – в группе сравнения.

Дополнительная терапия, направленная на коррекцию дисфункции эндотелия, предусматривала применение препарата L-аргинина (вазотон, Барнаул, РФ) в дозе 1,0 г в сутки в сочетании с ингибитором АПФ (эналаприл) 5 мг в сутки. Проведение ее начиналось за 3-4 суток до оперативного вмешательства. Противопоказанием к применению ингибитора АПФ считалась выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.). Больные с данным состоянием гемодинамики из исследования исключались.

Определение статистической значимости различий показателей в группах и в динамике осуществлялось по Манну-Уитни с использованием метода бутстреп [9].

Результаты. Основные результаты анализа показателей проведенного у больных раком головки поджелудочной железы, представлены на рисунках 1-3.

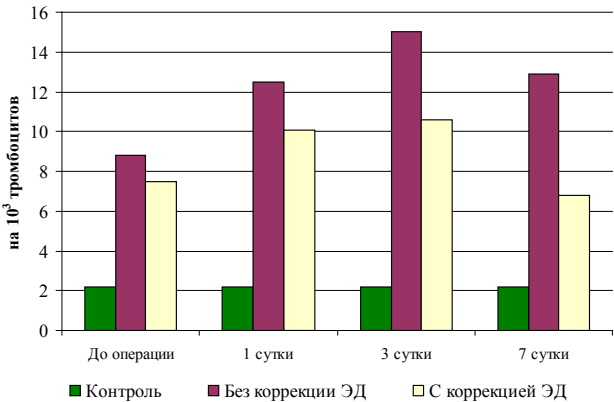


Рисунок 1 - Сравнительный анализ медианы содержания циркулирующих эндотелиоцитов у больных раком головки поджелудочной железы

Имелись статистически значимые отклонения показателей сосудистого эндотелия от значений в контрольной группе как до оперативного вмешательства, так и в динамике после его осуществления.

Число циркулирующих эндотелиоцитов резко превышало показатель контрольной группы в исходе ($Me/Me=3,41$), наиболее высоким было на 3-и сутки после операции ($Me/Me=4,82$), а на 7-е сутки снизилось ($Me/Me=3,09$, $p<0,01$ во всех случаях).

Между группами пациентов с раком головки поджелудочной железы, выделенными в зависимости от ведения, различия содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови наблюдались, начиная с 1 суток после оперативного вмешательства. В этот срок различия оказались статистически значимыми ($Me/Me=1,28$, $p<0,05$), на 3 сутки возросли до $Me/Me=1,56$ ($p<0,05$), а на 7 сутки – до $Me/Me=1,91$ ($p<0,01$). Как и в предшествующей группе, нами было выявлено протективное влияние проводимого в периоперационном периоде консервативного лечения на степень повреждения сосудистого эндотелия.

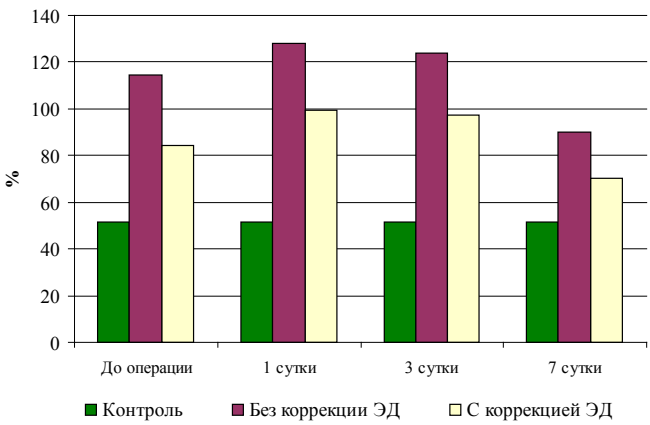


Рисунок 2 - Сравнительный анализ медианы содержания в крови фактора Виллебранда у больных раком головки поджелудочной железы

Этот факт подтверждается также результатами анализа содержания в крови ФВ. Данный показатель при обследовании до операции был относительно повышен относительно контроля ($Me/Me=1,63$), наиболее высоким оказался на 1 сутки ($Me/Me=1,92$) и далее также имел динамику к снижению. На 7 сутки различия с контролем составили 1,36 раза ($p<0,05$ во всех случаях).

Через 1 сутки после операции было зарегистрировано превышение показателя в группе сравнения по сравнению с основной ($Me/Me=1,21$, $p<0,05$). На 3 сутки уровень различий между группами больных оставался адекватным предшествующему ($Me/Me=1,28$, $p<0,05$), а на 7 сутки возрос до $Me/Me=1,54$ ($p<0,05$) за счет более быстрой динамики к компенсации в основной группе.

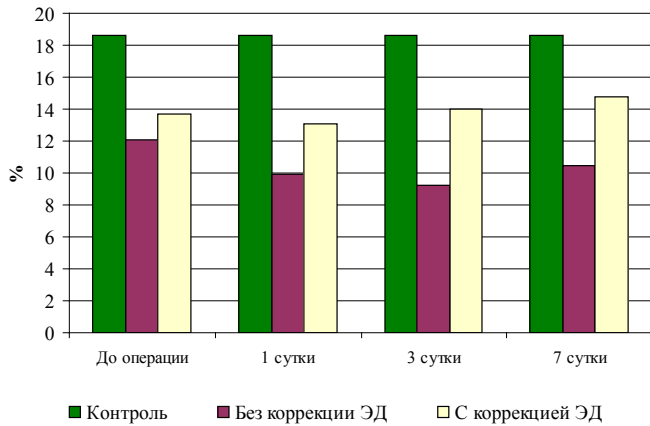


Рисунок 3 - Сравнительный анализ медианы ЭЗВД у больных раком головки поджелудочной железы

Уровень ЭЗВД в группе сравнения имел тенденцию к снижению в послеоперационном периоде. В основной группе, напротив, различия показателя с контролем через 7 суток были меньше, чем в исходном периоде исследования. Наиболее значимые различия по данному показателю были зарегистрированы на 1 сутки после операции ($RR=1,42$, $p<0,05$).

Данный показатель в исходе не имел статистически значимых различий между группами больных. Через 1 сутки после операции было зарегистрировано увеличение степени раз-

ницы, которая составила $Me/Me=1,36$ ($p<0,05$). На 3-и сутки различия между группами были максимальными и достигали $RR=1,55$ ($p<0,05$). Наблюдалось относительное уменьшение разницы между группами больных раком головки поджелудочной железы к 7-м суткам, но они оставались статистически значимыми ($Me/Me=1,42$, $p<0,05$).

В таблице 1 представлены клинические результаты лечения больных в зависимости от проводимой терапии.

Таблица 1 - Результаты лечения больных раком головки поджелудочной железы

Показатель	Группы больных				
	основная (n=44)		сравнения (n=51)		P
	абс.число	%	абс.число	%	
Наличие осложнений в раннем послеоперационном периоде	10	22,7	20	39,2	>0,05
Наличие рецидивов и/или метастазов	7	15,9	20	39,2	<0,05

Относительно умеренными, но тем не менее статистически значимыми были различия относительных величин частоты осложнений раннего послеоперационного периода ($RR=1,75$; $p<0,05$ при II клин. стадии и $RR=1,70$; $p<0,05$ – при III клин. стадии рака головки поджелудочной железы).

Напротив, в течение 2 лет проспективного наблюдения были выявлены очень значительные различия по частоте развития рецидивов и метастазов. Так, при II клинической стадии их степень достигала $RR=2,63$; $p<0,05$, а при III клин. стадии – $RR=2,34$; $p<0,05$. Невысокий уровень статистической значимости связан с небольшим количеством осложнений в основной группе.

Заключение. У больных раком головки поджелудочной железы были выявлены значительные нарушения функции сосудистого эндотелия. Они заключались в повышении содержания циркулирующих эндотелиоцитов, что свидетельствует о повреждении эндотелия [10] и снижение вазодилатирующих и антиагрегационных свойств. Данные изменения соответствовали клиническим результатам. В частности, при наличии выраженной эндотелиальной дисфункции отмечалось значительное повышение частоты осложнений раннего послеоперационного периода.

Следует отметить, что применение дополнительной терапии сочетанием L-аргинина и ингибитора АПФ, направленной на коррекцию эндотелиальной дисфункции, способствовало уменьшению числа осложнений, что мы связываем с коррекцией эндотелиальной дисфункции. Действительно, больные основной группы характеризовались снижением степени повреждения эндотелия, выражавшегося в значимом уменьшении числа циркулирующих эндотелиоцитов. Одновременно снижалось содержание проагрегантного фактора Виллебранда и увеличивался показатель эндотелийзависимой вазодилатации.

Данные изменения вполне могли бы являться основанием для улучшения состояния микроциркуляторного русла в области анастомоза и, более того, проходимости кровеносного русла на уровне артерий среднего калибра, что соответствует результатам, полученным другими авторами [11,12].

В целом, полученные результаты свидетельствуют о возможности применения разработанной методики лечения в комплексе периоперационного ведения больных раком головки поджелудочной железы и, потенциально, другими новообразованиями органов желудочно-кишечного тракта.

Список литературы

1. Matsuhashi N., Osada S., Yamaguchi K., Okumura N., et al. Long-term outcomes of treatment of gastric gastrointestinal stromal tumor by laparoscopic surgery: review of the literature and our experience// Hepatogastroenterology. Nov-Dec 2013. - Vol.60(128):2011. - №5.
2. Громов М.С., Александров Д.А., Кулаков А.А. и др. Диагностика и лечение распространенного рака желудка// Хирургия. - 2003. - 4. - С. 65-67.
3. Freitas A.A., Rocha B. The complex analysis of immune interaction between cancer cells and macroorganism// Annu.Reviuve Immunology. - 2000. - Vol.18. - P83-111.
4. Jones S.M., Roh M.S. Results of surgical resection for hepatocellular carcinoma // Cancer Treat Res. - 2001. - Vol. 109. - P. 59-75.
5. Mitsuyama H., Wallner K.E., Merrick G.S. Treatment of prostate cancer in obese patients // Oncology (Williston Park). - 2006. - Vol. 20, №10. - P. 1191-1197.
6. Головченко Ю.И., Трещинская М.А. Обзор современных представлений об эндотелиальной дисфункции// Consilium Medicum Ukraina. - 2008. - №11. - С. 17-25.
7. Di Costanzo F., Sdrobolini A., Gasperoni S. Possibilities of palliation in pancreatic cancer// Tumori. Jan-Feb 2009. - Vol. 85, №1. - P. 47-53.
8. Rajendran P., Rengarajan T., Thangavel J. et al. The Vascular Endothelium and Human Diseases// Int. J. Biol. Sci. - 2013. - Vol.9, №10. - P. 1057-1069.
9. Efron B., Tibshirani R.J. An introduction to the bootstrap. New York: Chapman & Hall, Software, 1993.
10. Burger D., Touyz R.M. Cellular biomarkers of endothelial health: microparticles, endothelial progenitor cells, and circulating endothelial cells// J. Am. Soc. Hypertens. - 2012. - Vol. 6, №2, - P. 85-99.
11. Durand M.J., Gutterman D.D. Diversity in mechanisms of endothelium-dependent vasodilation in health and disease// Microcirculation. - 2013. - Vol. 20, №3, - P. 239-247.
12. Vita J.A., Hamburg N.M. Does endothelial dysfunction contribute to the clinical status of patients with peripheral arterial disease?// Can. J. Cardiol. - 2010. - Vol. 26 Suppl A. - P. 45A-50A.

ТҰЖЫРЫМ

¹Олжаев С.Т., ²Сейсембаев М.А., ³Лазарев А.Ф.¹ШЖҚММК «Алматы Аймақтық Онкологиялық Диспансері», Алматы қ., Қазақстан Республикасы²Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы³Н.Н. Блохин атындағы Ресей онкологиялық ғылыми центр Алтай филиалы, Барнаул қ., Ресей

Ұйқыбезі басының обыры бар науқастардағы эндотелиалды дисфункцияны коррекциялау және оның клиникалық нәтижелері

Коррекциялау фонында операциялық араласулардан кейінгі эндотелиалды функция өзгерістерін талдау мақсатында II және III клиникалық сатыдағы ұйқыбезі басының обыры бар 95 науқас тексерілді. Эндотелий қызметінің көрсеткіштері мен айналымдағы эндотелиоциттер құрамы зерттелді.

Кешенді емдеу кезінде L-аргинин мен ангиотензин алмастырушы ингибиторларын қабылдау эндотелий зақымдалу дәрежесінің төмендеп, эндотелиалды дисфункцияның коррекциясын анықтады. Жасалған емдеу әдістерін қолдану асқыну санын азайтуға мүмкіндік берді.

Түйінді сөздер: Ұйқыбезі басының обыры; эндотелиалды дисфункция; L-аргинин; ангиотензин-алмастырушы фермент ингибиторы.

SUMMARY

¹Olzhayev S.T., ²Seisembayev M.A., ³Lazarev A.F.¹Almaty Regional Cancer Detection Centre, Almaty, Kazakhstan²Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan³Altai Branch of Blokhin Russian Cancer Research Center, Barnaul, Russian Federation

Correction of endothelial dysfunction in patients with cancer of the head of the pancreas and the clinical outcome

95 operated patients with cancer of the head of the pancreas of clinical stages II and III were examined to analyze the changes in endothelial function after surgery against correction. Function indicators of endothelium and circulating endothelial content were tested.

The use of L-arginine and ACE inhibitor in complex treatment decreased the endothelium damage and supported the correction of endothelial dysfunction. The developed methods of treatment were also associated with fewer complications.

Keywords: cancer of the head of the pancreas; endothelial dysfunction; L-arginine; angiotensin-converting enzyme inhibitor.



**1 февраля
в Казахстане стартовал декадник
по профилактике и раннему выявлению
онкозаболеваний**

В рамках Всемирного дня борьбы против рака с 1 по 10 февраля 2017 года во всех регионах страны пройдет декадник по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний под лозунгом «Мы можем! Я могу!» с акцентом на повышение физической активности.

Цель декадника: повышение осведомленности населения и медицинских работников по вопросам профилактики и раннего выявления онкозаболеваний, а также информирование населения о необходимости своевременного прохождения скрининговых обследований.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения РК. Отечественные медицинские организации располагают передовыми технологиями диагностики и лечения рака, которые позволяют добиться полного выздоровления пациента, особенно на ранних стадиях заболевания.

Скрининговые медицинские осмотры являются наиболее эффективным методом профилактики и ранней диагностики злокачественных опухолей. В 2016 году в республике в рамках онкологических скринингов проведено более **1,6 млн. обследований** целевых групп взрослого населения.

Напомним, Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно **4 февраля** по инициативе Международного противоракового союза.

